CSAPA FICTIF LE GRAND LARGE
21, rue des Fictifs - 33300 BORDEAUX
Tél. 05 00 00 00 21 Finess 33 0 99995 8

FAURIEL MELODIE N° dossier 2019-0388
Née le 11/02/1996 (29 ans)
IPP 0207719354
5 rue des Acacias, 33310 LORMONT

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation psychiatrique de suivi du 15/01/2024 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 19/01/2024 à 06:01 par BERTHOMIEU Agathe

Observations :
Vue ce jour, RDV trimestriel.
Stable sous BHD 8 mg/j en une prise le matin, pas de mésusage rapporté, pas d'injection. Plus d'héroïne depuis la mise sous TSO (2019).
Cannabis le soir, 2 a 3 joints "pour couper la journée". Tabac 15 cig/j.
Travaille comme caissière à temps partiel (24h), en couple avec M. CAZENAVE Jessy depuis 3 ans.
Implant retiré en novembre : projet d'enfant. Questions nombreuses sur la BHD pendant une grossesse -> informations données, pas d'indication à arrêter, au contraire.
Thymie neutre. Sommeil correct.
Conclusions :
RO BHD 8 mg QSP 28 j, délivrance hebdomadaire pharmacie
RDV 3 mois, plus tôt si grossesse

Observation infirmière du 04/03/2024 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 05/03/2024 à 06:00 par ROUSSILLE Quentin

Pte passée sans RDV, test urinaire de grossesse fait au CSAPA a sa demande : POSITIF. DDR vers le 20/01 (pas sure).
Tres angoissée, pleure, peur que "le bébé soit accro". A deja arreté le cannabis "depuis hier".
Réassurance. Dr BERTHOMIEU prévenue, RDV avancé au 07/03.

Observation psychiatrique de suivi du 07/03/2024 (Urgence : Bas)

Validé par BERTHOMIEU Agathe - Psychiatre le 07/03/2024 à 12:20

Observations :
Vue ce jour avec son compagnon.
Grossesse de 6 SA environ, désirée. Pas encore de suivi obstétrical.
Rappel des ATCD : héroïne sniffée vers 18 ans dans un contexte festif, puis Skenan achetés dans la rue, pas d'IV. TSO par BHD au CSAPA depuis 2019, aucune rechute franche depuis.
Explications sur le maintien de la BHD (risque de sevrage foetal à l'arret, pas de tératogénicité connue), sur le syndrome de sevrage néonatal possible et sa prise en charge. Bien compris par le couple, soulagement visible.
Cannabis : arret depuis le 03/03, sans difficulté majeure pour l'instant (sommeil un peu haché).
Tabac : 15 cig/j, accepte les patchs.
Conclusions :
- Maintien BHD 8 mg/j
- Substituts nicotiniques : patch 21 mg + gommes 2 mg
- Orientation maternité, consultation conjointe avec la sage-femme référente addicto (Mme LAPORTE)
- Kit naloxone remis
- Mise en lien ASS pour démarches

Entretien social du 21/03/2024 (Urgence : Bas)

Validé par MONTEIL Gaëlle - Assistante sociale le 22/03/2024 à 09:12

Premier entretien. Mme FAURIEL Mélodie, née le 11/02/1996, N° SS 2 96 02 33 249 117 39, domiciliée 5 rue des Acacias, 33310 LORMONT. Tél : 06 71 28 45 93.
Vit avec son compagnon M. CAZENAVE Jessy (livreur, CDD) dans un T2 au 3e sans ascenseur. Suivie au CSAPA "depuis 2018" selon elle.
Sa mère Mme FAURIEL Sandrine vit à proximité et pourra aider après la naissance.
Démarches : déclaration de grossesse à la CAF et à la CPAM, demande de logement social plus grand (dossier à compléter), contact PMI pour visites à domicile.

Consultation sage-femme du 18/04/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LAPORTE Romane - Sage-femme le 18/04/2024 à 16:40

Consultation conjointe CSAPA / maternité. Grossesse de 12 SA + 3 j. Échographie du 1er trimestre normale. Terme prévu

le 27/10/2024.
Usage d'héroïne de 20 à 23 ans, sous BHD depuis. BHD 8 mg/j, bien tolérée. Nausées matinales sans vomissements.
Cannabis arrêté depuis plus d'un mois. Tabac diminué à 8 cig/j avec les patchs.
Projet de naissance abordé : allaitement souhaité, compatible avec la BHD. Information sur l'hospitalisation possible du bébé en néonatologie.
Prochaine consultation à 22 SA.

Observation psychiatrique de suivi du 30/05/2024 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 07/06/2024 à 06:02 par BERTHOMIEU Agathe
Observations :
Vue ce jour, 18 SA.
Dit avoir consommé de l'héroïne mi-mai, "une trace" chez une ancienne amie croisée par hasard, en parle spontanément avec beaucoup de culpabilité. Pas d'autre prise depuis. Urines du jour : buprénorphine +, opiacés -, THC -.
Craving en fin de journée, sensation de manque légère le soir (baillements, jambes sans repos). Nausées ++ le matin.
Thymie légèrement abaissée, anxiété anticipatoire sur l'accouchement et sur le regard de l'équipe de maternité. Pas d'idées suicidaires.
Conclusions :
Majoration BHD 10 mg/j (6 mg le matin + 4 mg le soir), ordo transmise pharmacie
Entretien avec Mme LAPORTE pour préparer le staff de périnatalité
RDV 1 mois

Observation psychiatrique de suivi du 25/07/2024 (Urgence : Bas)

Validé par BERTHOMIEU Agathe - Psychiatre le 25/07/2024 à 11:05
Observations :
Vue ce jour, 26 SA environ.
Pas de nouvelle consommation d'héroïne. Signes de manque en fin de journée malgré le fractionnement, attendus au 3e trimestre (augmentation du volume de distribution).
Bonne alliance, investie dans le suivi de grossesse. Le couple prépare la chambre.
Conclusions :
BHD 12 mg/j (8 + 4) à partir de demain
Staff périnatalité le 02/08 (maternité, PMI, CSAPA)

Délivrance du 14/08/2024 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 15/08/2024 à 06:00 par ROUSSILLE Quentin
Délivrance exceptionnelle au CSAPA (pharmacie fermée pour congés). BHD 10 mg remis pour 3 jours. Pte fatiguée, chaleur ++, pas d'odeur d'alcool ni de signes d'intoxication.

Consultation sage-femme du 03/10/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LAPORTE Romane - Sage-femme le 03/10/2024 à 14:15
Accouchement le 29/09/2024 à 36 SA + 2 j, voie basse : naissance de son fils Kenzo, 2 610 g.
Syndrome de sevrage néonatal à J2, score de Finnegan maximal à 11 : morphine orale pendant 6 jours en néonatologie.
Sortie de l'enfant prévue le 08/10.
Mme FAURIEL tire son lait, allaitement poursuivi. Très présente auprès de son fils. Fatiguée.
Visites PMI à domicile organisées dès la sortie.

Observation psychiatrique de suivi du 22/10/2024 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 26/10/2024 à 06:01 par BERTHOMIEU Agathe
Observations :
Vue ce jour avec Kenzo (3 semaines).
Fatigue intense, pleurs fréquents depuis le retour a domicile, sentiment de ne pas être une bonne mere ("il a souffert à cause de moi"). Sommeil très fragmenté. EPDS à 14.
Tabac repris a 15 cig/j. Cannabis : "un le soir pour dormir" depuis la sortie de maternité.

BHD 12 mg/j inchangée.
Conclusions :
A revoir dans 15 jours, vigilance dépression du post-partum
Consultation psychologue périnatalité à proposer
Pas de modification du TSO pendant l'allaitement

Entretien social du 12/12/2024 (Urgence : Bas)

Validé par MONTEIL Gaëlle - Assistante sociale le 12/12/2024 à 15:47
Mme FAURIELL indique que M. CAZENAVE est parti du domicile début décembre après plusieurs disputes. Elle reste seule avec Kenzo dans le T2.
Demande d'ouverture de droits RSA majoré (parent isolé) et révision des APL. Relance du bailleur pour la demande de mutation.
La PMI passe toutes les semaines, rien d'inquiétant concernant l'enfant selon la puéricultrice.

Observation psychiatrique de suivi du 23/01/2025 (Urgence : Bas)

Validé par BERTHOMIEU Agathe - Psychiatre le 23/01/2025 à 18:02
Observations :
Vue ce jour, avec sa mere qui garde Kenzo en salle d'attente.
Séparation "depuis Noël" vécue comme un abandon. Tristesse quasi permanente depuis plusieurs semaines, anhédonie, culpabilité ++ vis-à-vis de son fils, ralentissement. Pas d'idées suicidaires ni d'idée délirante concernant l'enfant. Mange peu.
Tableau d'épisode dépressif caractérisé du post-partum, d'intensité modérée.
Allaitement arreté depuis début janvier.
A diminué d'elle-meme la BHD à 10 mg depuis le 06/01 ("pour en prendre moins"), pas de manque.
Conclusions :
- Introduction sertraline 50 mg le matin
- Psychologue de la PMI : 1er RDV en février
- BHD 10 mg, RO
- RDV 3 semaines

Observation psychiatrique de suivi du 06/03/2025 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 13/03/2025 à 06:00 par BERTHOMIEU Agathe
Observations :
Vue ce jour.
Amélioration nette depuis la majoration de la sertraline a 100 mg le 20/02, meilleur élan, s'occupe avec plaisir de son fils (5 mois), sort de nouveau. Voit la psychologue de la PMI tous les 15 jours depuis février.
Cannabis 1 a 2 joints le soir. Tabac 12 cig/j.
Pense reprendre le travail en septembre, demande de place en creche faite.
Conclusions :
RO sertraline 100 mg + BHD 10 mg
RDV 6 semaines

Observation infirmière du 15/05/2025 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 16/05/2025 à 06:00 par ROUSSILLE Quentin
Pte venue chercher son ordonnance, RDV médical manqué le 13. Dit avoir sniffé de l'héroïne samedi soir 10/05 chez une amie, "une fois", Kenzo gardé par sa mère. Pas d'autre produit.
Nouveau kit naloxone remis (l'ancien périmé). RDV médical reprogrammé le 22/05.

Observation psychiatrique de suivi du 22/05/2025 (Urgence : Bas)

Validé par BERTHOMIEU Agathe - Psychiatre le 22/05/2025 à 17:30
Observations :
Vue ce jour.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Reprise ponctuelle d'héroïne le 10/05, une prise unique, dans un contexte de fatigue et d'isolement (Kenzo malade, nuits blanches). Analyse fonctionnelle faite : solitude du samedi soir, manque d'étayage. Pas de perte de contrôle ; aucune reprise depuis.
Signes de manque le soir depuis la diminution de janvier.
Place en creche obtenue a partir de juin, sa mère garde Kenzo le samedi.
Thymie stable.
Conclusions :
BHD 12 mg/j (8 + 4), RO 28 j
Sertraline 100 mg inchangée
RDV 2 mois

Observation psychiatrique de suivi du 09/09/2025 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 15/09/2025 à 06:02 par BERTHOMIEU Agathe
Observations :
Vue ce jour.
A repris le travail le 01/09 a mi-temps, contente. Kenzo à la creche depuis juin, s'est bien adapté.
Euthymique. Plus d'héroïne depuis mai. Cannabis occasionnel le week-end. Tabac 10 cig/j, souhaite arreter "pour le petit" : reprise des patchs.
Conclusions :
- BHD 12 mg, sertraline 100 mg : RO
- Patch nicotinique 14 mg + forme orale
- Point sevrage tabac avec l'IDE tabacologue
- RDV 2 mois